

RAPPORT DE SYNTHÈSE NEUROPSYCHOLOGIQUE — VERSION v3

Évaluation du TBDAHPS / TDAPH, Modélisation Neuro-Cognitive et Correspondance DSM-5-TR

I. MOTIF DE CONSULTATION ET HISTORIQUE CLINIQUE

Le présent document constitue un dossier de cadrage clinique et de synthèse neuropsychologique approfondie v3. La démarche s'inscrit dans l'évaluation et l'officialisation d'un profil neurodéveloppemental atypique caractérisé par une alternance attentionnelle biphasique, un traitement associatif en parallèle (multi-threading) et une réactivité exécutive liée à la saillance des stimuli. Les manifestations observées correspondent au Trouble du Déficit d'Attention avec Hyperactivité (TDAH) de présentation combinée selon les critères du DSM-5-TR (Code 314.01 / F90.2) et de la CIM-11 (Code 6A05.2).

II. DESCRIPTION DU PROFIL NEUROCOGNITIF ET DYNAMIQUE ATTENTIONNELLE

1. Structure Attentionnelle Biphasique (Phase Vibe vs Phase Nickel)

Le fonctionnement attentionnel du sujet ne traduit pas un déficit passif de capacité, mais une régulation biphasique gouvernée par le besoin de stimulation et la valeur de saillance des tâches :

- **Phase Vibe (Sous-stimulation / Routine / TDA)** : En contexte neutre ou répétitif, dominance du Réseau du Mode par Défaut (DMN), entraînant une distractibilité importante, une labilité de la focalisation et des sauts associatifs arborescents.
- **Phase Nickel (Haute saillance / Hyperfocus / TDAH)** : Lors de l'engagement sur des tâches complexes ou stimulantes, désactivation du DMN et verrouillage du Réseau Exécutif Central (CEN), produisant un hyperfocus d'une densité extrême et une vitesse de traitement élevée.

2. Connectivité Cérébrale et Atemporalité Perceptive (Time Blindness)

- **Multi-threading Cognitif** : Traitement simultané de plusieurs flux d'idées, traduisant une hyper-connectivité fonctionnelle du DMN.
- **Time Blindness** : Altération de la perception de la durée, où le temps perçu varie selon l'état d'engagement attentionnel et la charge émotionnelle.
- **Intégration Sensorielle** : Sensibilité élevée aux sur-stimulations environnementales (bruit, agitation), nécessitant une phase de régulation préfrontale.

III. FORMALISATION DU TBDAHPS / TDAPH ET MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

La structure cognitive du TBDAHPS (Trouble du Déficit d'Attention avec HyperActivité Biphasique Alternante Stimulative Prioritaire) ou TDAPH (Trouble du Déficit d'Attention Parallélodexe avec HyperActivité) est formalisée par la relation tensorielle :

Équation Tensorielle du TBDAHPS :

$$TDA_{Ni}^{Ni^3} \otimes TDAH_h^{Ni^3} = TDAPH$$

Équation Maître de Conscience Active (PtXhEe-5D) :

- $P_{taxi}(t) + X \cdot h(t) \cdot E(t)^2 \cdot \xi(t) = \Omega(t)$
- $P_{taxi}(t)$: Vectorisation de l'intention directionnelle (méta-cognition).
 - $E(t)^2$: Énergie synaptique quadratique (vélocité non-linéaire lors des pics d'hyperfocus).
 - $h(t)$: Densité temporelle de réflexion (capacité d'inhibition préfrontale / temps d'arrêt).
 - $\xi(t)$: Coefficient de contraste sémantique (chaos, friction, second degré, réactivité).
 - $\Omega(t)$: Perception finale et intégration du sens.

Seuil de Tension Critique (T_c) & Imploxxion :

$$T_c = (E^2 \cdot \xi) / h$$

Afin d'éviter la saturation ou le sur-régime cognitif, le système déclenche une élévation de l'inhibition préfrontale (h), provoquant une compression interne de la complexité (imploxxion) pour maintenir l'homéostasie.

IV. MATRICE DE CORRESPONDANCE CLINIQUE ET NOSOLOGIQUE (DSM-5-TR / CIM-11)

Afin d'inscrire fidèlement le profil dans la nomenclature médicale et psychiatrique officielle pour l'officialisation diagnostique, les manifestations observées sont traduites selon les codes de référence :

Concept / Manifestation Clinical	Diagnostic Médical / Nosologie	Code Officiel DSM-5-TR / CIM-11
Alternance distractibilité / Hyperfocus sélectif	TDAH — Présentation Combinée	DSM-5-TR : 314.01 (F90.2) CIM-11 : 6A05.2
Traitement en parallèle / Sauts associatifs	Hyper-connectivité du Réseau du Mode par Défaut (DMN)	Marqueur Neurocognitif
Atemporalité perceptive (Time Blindness)	Dysfonctionnement Exécutif Préfrontal	Déficit Exécutif Spécifique
Surcharge cognitive en milieu bruyant	Profil d'intégration sensorielle atypique	Hyper-réactivité Sensorielle
Bascule brusque pôle analytique / affectif	Labilité de régulation dopaminergique & émotionnelle	Composante associée au TDAH adulte

V. RÉSULTATS DE LA SIMULATION ATTENTIONNELLE CPT-3

L'évaluation empirique des temps de réaction et du taux d'omissions (type Conners' Continuous Performance Test CPT-3) met en évidence la dissociation franche entre la phase de sous-stimulation et la phase d'hyperfocalisation :

Profil CPT-3 Biphasique : Dissociation entre Labilité (T-Score 68) et Hyperfocus (T-Score 42)

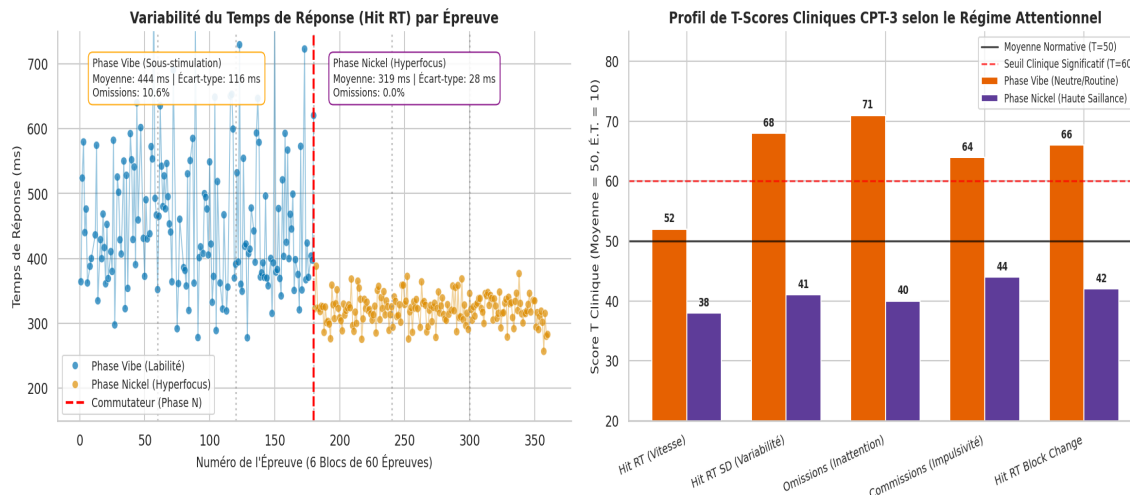


Figure 1 : Profil de performance CPT-3 montrant la rebasculée de T=71 (inattention clinique) à T=40 (zone optimale) sous hyperfocus.

VI. RECOMMANDATIONS POUR LE BILAN ET LETTRE OFFICIELLE DE RÉFÉRENCE

Afin de constituer un bilan étalonné, falsifiable et opposable sur le plan clinique, la batterie de tests suivante est recommandée :

- **Capacités Intellectuelles Générales** : WAIS-IV (Analyse des dissociations inter-indices ICV, IRP, IMT, IVT).
- **Fonctions Attentionnelles** : CPT-3 (Continuous Performance Test) et TAP (Attention soutenue, sélective, divisée).
- **Fonctions Exécutives & Inventaires** : BRIEF-A (Évaluation de l'inhibition et de la flexibilité) et entrevue DIVA-5.

LETTRE DE RÉFÉRENCE CLINIQUE POUR ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE

À l'attention du clinicien / neuropsychologue évaluateur :

Je vous adresse le patient pour la réalisation d'un bilan neuropsychologique complet axé sur l'évaluation des fonctions attentionnelles et exécutives. Le tableau clinique évoque un **Trouble du Déficit d'Attention avec Hyperactivité (TDAH) — Présentation Combinée (DSM-5-TR 314.01 / CIM-11 6A05.2)**, se traduisant par une labilité attentionnelle en sous-stimulation compensée par des états d'hyperfocalisation sélective d'une densité exceptionnelle. Le bilan permettra d'étalonner les indices attentionnels (omissions, variabilité Hit RT SD), de cartographier le profil exécutif préfrontal et d'accompagner la démarche d'officialisation diagnostique et de prise en charge adaptée.